



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : تهاني مصطفى سليمان السيد
المحافظة : الفيوم الحى / المدينة : طاميه
رقم البطاقة : 28502202302409 رقم التليفون : 01029236114
العنوان : قصر رشوان-
العمر (تاريخ الميلاد) : 20-02-1985 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: تهاى مصطفى سليمان السيد National ID: 28502202302409	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية الأردن
إمارة تخمق الشخسة

تهانى
مصطفى سليمان السند

قصر رشوان
مركز طامبة - القنوم

١٩٨٥/٠٣

٢٨٥٠٢٢٠٢٣٠٢٤٠٩

KM0166858



٢٠٢٤/٠٣

٢٨٥٠٢٢٠٢٣٠٢٤٠٩

فلاحه

متزوجة

مسلمة

انثى

سالم عنى عبدالسميع صانع

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٣/٠٤





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID#

1- ID#

كود المريض

Sex

MDT form

2- Medical numbers

Female

03132298

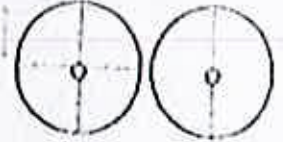
Old Med #

Old Med #

1021-2023

2-10 numbers 28502202302400

Patient Age 39 Y



Family history

Family history
+ve

Phone

Phone

01000176047
01029236114

BRE

g 2c

REASON OF HOT

REASON OF HOT
POST OPERATIVE

marital status

Marital status
Married

HRB Score

HRB Score

GROUP

GROUP

Date of HOT

Date of HOT

2023-11-11

to morbidity

to morbidity
free

Menopausal
status

Menopausal status
Perimenopausal

Breast Imaging 1

Mets Workup 1
CT CAP/FREE
bone scan free

BX

10C

EXCISE

ER

8/8

EXCISE

PR

8/8

EXCISE

Her 2 Neu

Her 2 Neu

Her 2 Neu

Her 2 Neu

91911

EXCISE

X167

40

Y

4d

N

1

M

0

Sonomammography

LY LABC MULTICENTRIC LY 10 OCLOCK 5+. CM REACH TO NIPPLE
WITH IPISILATERAL PATHOLOGICAL AXILLARY LN

PATIENT HISTORY

pt received 4 DD AC + 12 weeks taxol

LY MRM:

YPTO YPN1

free deep margins&NAC

LN 1/23WXTOUT EXTRA Capsular Infiltration

partial pathological response

RECOMMENDATION

FOR PORT, ZOLADEX/AT 5 YS AND CONSIDER EXTENDED
PROLTA/GMN FOR 3 YS AFTER DENTAL

MEDICAL ONCOLOGY

Medical Oncology
2023/11/11

RADIOLOGY

Radiology
2023/11/11

Patient Name : الأستاذ / نهالي مصطفى سليمان السيد
Patient No. : 28502202302409
Path No. : 3409/23
Sex : Female
Age : 38 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002815
Request Date : 07/10/2023
Verification Date : 22/10/2023
Financial Category : ارقام دار السلام - مبلره
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer (post NACT) .

Nature of the specimen: Left MRM

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM
- measured 25x25x6 cm with covering skin ellipse measured 25x18 cm & attached axilla 10x9 cm .
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 4x3 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 3cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size: 23 L.Ns up to 2x1 cm .
- Rest of breast showed thickened grayish white tissue in dilated ducts.

Microscopic examination:

- Histological type: No residual viable tumor tissue detected
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive one L.N (1/23) with no extracapsular extension.
- Resection Margins: Free deep margin.
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response.

Diagnosis:

Left MRM (post NACT) :

- Total burned out tumour (No residual viable tumor tissue detected).
- Free deep margin.
- Free nipple and areola

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 24/10/2023 11:25:46

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



شراة رقم (4) - الدور الأول - البناية رقم (987) - مبنى رقم (4) - الدور الأول - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987 - Nda Corulche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : السيد / د. هادي مصطفى مكي
Patient No. : 28502202302409
In No. : 586/2023
Sex : Female
Age : 38 Y
Referring Doc. :
Request No. : 13005552
Request Date : 27/02/2023
Verification Date : 19/03/2023
Financial Category : اورام دار السلام - مبالغه
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:

1. Breast mass.

2. Core of specimen:

1. Core biopsy, collected at 26/2/2023, 10:30 am

3. Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.

Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, IHC clone (1 E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

4. Microscopic Examination:

1. Histological type: Invasive duct carcinoma.

2. Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+3+3) Grade III

3. IHC: not detected

4. Lymphovascular invasion: Couldn't be detected in the received biopsy

5. IHC (Positive control showed appropriate reactivity):

ER: Strong nuclear reaction in 90 % of tumor cells (Allred score 8/8).

PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).

Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).

Ki67: 40% nuclear reaction of tumor cells.

6. DIAGNOSIS:

1. Invasive breast mass, Tru cut biopsy:

2. Invasive duct carcinoma, Grade III.

3. IHC:

4. ER: Positive (score 8/8).

Verified by :

DR. Menna Nabil

Reporting Date : 19/03/2023 11:22:13

Page 1 of 3

Printed By : DR. Menna Nabil

Patient Name: الأستاذة / نهدي مصطفى مبارك السيد
Patient No.: 28502202302409
Path No.: 586/2023
Sex: Female
Age: 38 Y
Referring Doc.:

Request No.: 13005552
Request Date: 27/02/2023
Verification Date: 19/03/2023
Financial Category: اورام خارج العظام - ميثاقه
Department: Out Patient

Registered by: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

PR: Positive (score 8/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 40% of tumor cells

Scoring system: *ER, PR*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: *Her2*

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within ? 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within ? 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Iman Gouda
Dr. Hebatallah Mostafa

Verified by:
DR. Monna Nabil

Printing Date : 19/03/2023 11:22:13

Page 2 of 3

Printed By : DR. Monna Nabil

Report generated by the Pathology Lab, Ministry of Health, Egypt.
For more information, please contact the Pathology Lab, Ministry of Health, Egypt.



Exam Information:

<u>Patient Name:</u> D Mustafa	<u>Date of birth:</u> 20/02/1985
<u>Arabic Name:</u> نهالى مصطفى	<u>Patient Gender:</u> F
<u>Patient RIS ID:</u> 332179	<u>Exam Date:</u> 22/07/2023
<u>Patient HIS ID:</u> 123014436	<u>Approved by:</u>
<u>Written by:</u>	Dr. Hoda Fathy
Dr. Hoda Fathy	

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (22/07/2023)

• blood pool Anterior and Posterior Images for 1000k count followed by Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Dr/Mayadah Ashraf
Nahla Mamoun, MSc

Much Obliged

MUSTAFA SULAIMAN, D Patient ID: 123014436 DOB: 20-Feb-1985 Date: 05-Sep-2026

Patient Lastname: Mustafa Sulaiman

Patient Firstname: D

HIS Patient ID: 123014436

RIS Patient ID: 332179

Date of Birth: 20/02/1985

Procedure: 15660, MRI Hip Joints with Contrast

Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

Mri of both hips and upper femur :

" Normal bone marrow signal

" Normal hip joint

" No sizable soft tissue masses

Dr manal Refaat

===== REPORT TEXT END =====

Approved By: MANAL M